Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Judicial da Comarca de Canela

Rua Dona Carlinda, 415 - Bairro: Centro - CEP: 95680224 - Fone: (54) 3022-9839 - Email: frcanelavjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5006151-06.2023.8.21.0041/RS

AUTOR: ADRIELI CATIANE SILVA RAMOS

RÉU: UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA.

SENTENÇA

ADRIELI CATIANE SILVA RAMOS ajuizou ação de obrigação de fazer contra **UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA**, ambas já qualificados nos autos. Narrou, em suma, que é usuária do plano de saúde da ré e foi diagnosticada com neuromielite óptica - NMOSD (CID 10 G36), sendo indicada a utilização do medicamento *Inebilizumab 100mg/10mL.* Informou que a requerida indeferiu o pedido administrativo para fornecimento do fármaco, sob o fundamento de que não se encontra no rol da ANS. Teceu comentários acerca da necessidade de utilização do medicamento, bem como da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Teceu considerações sobre os danos morais suportados. Requereu, em sede de tutela antecipada, o fornecimento do tratamento e, ao final, pela a procedência da ação, com a confirmação da liminar e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00. Postulou a concessão da gratuidade de justiça. Juntou documentos (evento 1).

Concedida a gratuidade de justiça e indeferida a liminar (evento 3).

Citada (evento 11), a requerida contestou a ação. Preliminarmente, impugnou o valor da causa, a gratuidade de justiça concedida à autora e alegou inépcia da inicial. No mérito, aduziu que a autora agiu de má-fé ao alegar que a negativa assistencial foi fornecida de forma oral, tendo em vista que a negativa estava disponível desde 25/08/2023, ou seja, antes do ajuizamento da ação. Alegou ser legítima a negativa de fornecimento do medicamento, tendo em vista o parecer negativo do CONITEC. Teceu considerações sobre a taxatividade do rol de procedimentos da ANS. Pediu pela improcedência da ação e condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Juntou documentos (evento 13).

A liminar foi concedida pelo TJRS (evento 17).

A parte autor apresentou réplica (evento 22).

Instadas as partes sobre o interesse na produção de provas (evento 25), nada foi requerido.

Em despacho saneador, as preliminares foram afastadas (evento 132).

O Ministério Público declinou da intervenção (evento 138).

É o relatório.

Decido.

Julgo o feito no estado em que se encontra, na forma do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, haja vista que se trata de matéria eminentemente de direito, não sendo necessária a produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

<u>Preliminar - Impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora</u>

Conforme documentos anexados ao evento 139, verifico que a autora preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, pois aufere renda mensal inferior a cinco salários-mínimos, já que não declara imposto de renda.

Por outro lado, as alegações apresentadas pela parte ré não foram corroboradas com elementos probatórios suficientes para desconsiderar os documentos referidos, impondo-se a manutenção da benesse, pois preenchidos os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil.

<u>Mérito</u>

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, em que pretende a parte autora que a ré seja compelida a fornecer o medicamento *Inebilizumab 100mg/10mL.* Para tanto, aduziu que foi diagnosticada com neuromielite óptica - NMOSD (CID 10 G36) e o requerido negou o fornecimento do tratamento.

Inicialmente, cumpre consignar que os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação de consumo.

Aliás, sobre o tema em discussão o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº 608, a qual dispõe que "*aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".*

Com efeito, os planos de assistência à saúde devem se submeter às regras constantes na legislação consumerista, para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, considerando a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, bem como manter a base do negócio a fim de permitir a continuidade da relação no tempo.

Destarte, estando os contratos submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se, dentre outras, as seguintes regras: "*As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor"* (art. 47 do CDC). E, considerar-se-ão abusivas, as que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada; sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor e as que se mostrem exageradas, como as excessivamente onerosas ao consumidor, as que restrinjam direitos ou ofendam princípios fundamentais do sistema (art. 51, incisos IV e XV e § 1º, incisos, I, II e III, do CDC).

Na hipótese dos autos, há prova inequívoca, consubstanciada no laudo médico, que comprova que a autora é portadora neuromielite óptica - NMOSD (CID 10 G36). De igual modo, restou demonstrada a necessidade de início imediato do tratamento pelo médico assistente, nos seguintes termos (evento 1, LAUDO8):

> *"Atesto a pedido e para fins de retirada de medicação de controle especializado, que paciente acima apresenta patologia de código CID 10 G36 (Neuromielite óptica - NMOSD), conforme anticorpo específico positivo, sendo que esta doença neurológica não tem protocolo clínico de diretrizes terapêuticas (PCDT) disponível, motivo pelo qual não há disponibilidade de solicitação de medicação conforme outras doenças via laudo médico especializado por PCDT. A sra. Adrieli teve o primeiro surto da doença em fevereiro de 2021, apresentando quadro de mielite inflamatória, chegando a ficar tetraparética, restrita a cadeira de rodas. Na época fez pulsoterapia com poucoa resposta e apresentou anti-aquaporina 4 reagente (1:40) e iniciou azatioprina. Em junho/julho de 2021, com piora da força nos membros inferiores, fez tratamento com imunoglobulina humana endovenosa, com recuperação da força em membros superiores e recuperação parcial em membros inferiores, mas ainda com muita dificuldade de locomoção (uso de andador). Em outubro de 2021 iniciou tratamento com rituximabe, porém, em abril de 2022, consulta por piora clínica- diminuição de força nos membros inferiores e dor importante em região coluna dorsal e em membros inferiores. Associado mediações para dor neuropática (carbamazepina, pregabalina e amitriptilina). Em dezembro de 2022 retorna ainda com dor em região dorsal, além de formigamento importante em mãos e pés e incontinencia fecal. Neste momento, opta-se pela troca de rituximabe por inebilizumabe, conforme orientação médica.*
>
> *A NMOSD é uma doença autoimune rara, causada por uma inflamação no sistema nervoso central, resultando em surtos graves e recorrentes que podem levar a incapacidade permanente, como comprometimento motor, esfincteriano e perda da visão. Estima-se que 10 mil pessoas no Brasil convivam com a doença. Um dos principais objetivos do tratamento é auxiliar a prevenir danos cumulativos e incapacidade permanente que podem ser causadas por surtos subsequentes.*
>
> *Em 19 de dezembro, a ANVISA aprovou a primeira e única medicação para o tratamento da NMOSD: o inebilizumabe (UPLIZNA). Trata-se de uma droga depletora de células B (anti-CD19) para o tratamento de adultos soropositivos para a imunoglobulima G antiaquaporina-4 (APQ4+).*
>
> *No principal ensaio clínico N-MOmentum (em anexo), a terapia com inebilizumabe demonstrou uma redução significativa no risco de um surto de NMO com apenas duas infusões por ano, em que 87% dos pacientes permaneceram livres de surtos por pelo menos quatro anos de tratamento*
>
> *Portanto, a paciente acima necessita fazer uso contínuo de medicação de controle especializado, conforme receita médica em anexo, a fim de diminuir incidência de surtos clínicos, melhorar qualidade de vida e reduzir morbidade secundária à doença neurológica. Caso fique sem medicação imunossupressora, há risco de neurite óptica com chance de seqüela visual permanente e mielite transversa com chance de seqüela permanente em deambulação, motivo pelo qual solicita-se urgência no início do tratamento solicitado (inebilizumabe)".*

Por sua vez, as coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei nº 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma Lei.

Além disso, sobreveio a publicação da Lei Federal nº 14.454, que alterou a Lei Federal nº 9.656/1998, especialmente, acrescentou os parágrafos 4º, 12 e 13 ao artigo 10, a qual ampliou a cobertura dos tratamentos de saúde, viabilizando sua concessão mesmo que não prevista no Rol da ANS, mas desde que obedeça os requisitos nela impostos, *in verbis:*

> *"Art. 10.*
>
> *§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.*
>
> *§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.*
>
> ***§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:***
>
> ***I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou***
>
> ***II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."****(grifei)*

Desta feita, conclui-se que os tratamentos de saúde e medicamentos não constante no Rol da ANS poderão ter sua cobertura concedida, desde que exista comprovação da eficácia ou exista recomendação de órgão competente.

Outrossim, consistindo em tratamento de uso ambulatorial, e não domiciliar, afigura-se obrigatória a cobertura, por se tratar de exigência mínima de fornecimento, nos termos do art. 12, I, alínea "b", da Lei nº 9.656/98.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO INJETÁVEL. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim" (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).

2. "A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.155.621/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)(grifei)

Da análise da prescrição médica, verifica-se que o medicamento é de uso ambulatorial, sendo aplicado de forma intravenosa (evento 1, RECEIT9), com supervisão médica.

Ademais, conforme constou na decisão que concedeu a tutela antecipada pelo TJRS *"denota-se a existência de diversas notas técnicas favoráveis extraídas do sistema e-NatJus (Notas Técnicas nºS 154769, 161035 e 163145), editadas recentemente, as quais demonstram a eficácia à luz das evidências científicas do fármaco para tratamento da patologia que acomete a parte autora"*[1].

Deste modo, considerando que o medicamento encontra-se registrado na ANVISA, com notas técnicas favoráveis emitidas pelo E.NatJus e, ainda, tratando-se de medicamento de uso ambulatorial, é dever da requerida fornecer o tratamento à autora.

Nesse sentido, é o entendimento do TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME APELAÇÃO CÍVEL CONTRA SENTENÇA QUE DETERMINOU A COBERTURA DO MEDICAMENTO SPRAVATO PARA TRATAMENTO DE DEPRESSÃO E CONDENOU A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.A OPERADORA APELANTE SUSTENTOU QUE A NEGATIVA DE COBERTURA FOI LÍCITA, POIS O MEDICAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS E NÃO FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA COBERTURA. INSURGIU-SE, AINDA, CONTRA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALEGANDO QUE A NEGATIVA DECORREU DE INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL PLAUSÍVEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) SABER SE HÁ OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO MEDICAMENTO SPRAVATO, DIANTE DE SUA CLASSIFICAÇÃO COMO DE USO AMBULATORIAL; E (II) VERIFICAR SE A NEGATIVA DE COBERTURA, AMPARADA EM INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DO CONTRATO E DO ROL DA ANS, ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ***III. RAZÕES DE DECIDIR4. O MEDICAMENTO SPRAVATO POSSUI ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AMBULATORIAL, CONFORME SUA BULA, EXIGINDO MONITORAMENTO PROFISSIONAL. ASSIM, NÃO SE ENQUADRA NA EXCLUSÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98, SENDO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA PELOS PLANOS DE SAÚDE.5. O STJ FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS OU INTRAVENOSOS QUE NECESSITAM DE SUPERVISÃO MÉDICA NÃO SÃO CONSIDERADOS DE USO DOMICILIAR E, PORTANTO, NÃO PODEM SER EXCLUÍDOS DA COBERTURA ASSISTENCIAL.****6. QUANTO AO DANO MORAL, A JURISPRUDÊNCIA DO STJ RECONHECE QUE A NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO, QUANDO BASEADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL DE INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL E NA AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA DA OPERADORA, NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.7. NO CASO CONCRETO, EMBORA A NEGATIVA DE COBERTURA TENHA SIDO INCORRETA, DECORREU DE INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL PLAUSÍVEL, SEM DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ OU ABUSO, AFASTANDO-SE A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. IV. DISPOSITIVO E TESE8. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.TESE DE JULGAMENTO: "1. O MEDICAMENTO SPRAVATO (ESKETAMINA), POR SER DE USO AMBULATORIAL E EXIGIR ADMINISTRAÇÃO SOB SUPERVISÃO PROFISSIONAL, DEVE SER COBERTO PELOS PLANOS DE SAÚDE, INDEPENDENTEMENTE DE SUA PREVISÃO NO ROL DA ANS. 2. A NEGATIVA DE COBERTURA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL RAZOÁVEL NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, DANO MORAL INDENIZÁVEL." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: LEI Nº 9.656/98, ART. 10, VI.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AGINT NO RESP 2.155.621/PB, REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3ª TURMA, J. 14.10.2024; STJ, AGINT NOS ERESP 1.895.659/PR, REL. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 2ª SEÇÃO, J. 29.11.2022; STJ, AGINT NO RESP 2.108.519/SP, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4ª TURMA, J. 15.04.2024.(Apelação Cível, Nº 50168487520248210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 20-03-2025)(grifei)*

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ACLASTA (ÁCIDO ZOLEDRÔNICO). PACIENTE COM OSTEOPOROSE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MEDICAMENTO DE USO AMBULATORIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Aclasta (ácido zoledrônico) à paciente diagnosticada com osteoporose, conforme prescrição médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se a operadora do plano de saúde pode negar cobertura ao medicamento prescrito ao beneficiário, sob a alegação de que não está incluído no rol da ANS e de que se trata de medicação de uso domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR3. ***O medicamento Aclasta é administrado por via intravenosa e exige acompanhamento médico, configurando-se como de uso ambulatorial, e não domiciliar, o que justifica a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.****4. O rol da ANS não é taxativo, podendo ser excepcionado quando há prescrição médica fundamentada e evidências científicas da eficácia do tratamento. IV. DISPOSITIVO5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção. JRS, AI nº 51592971120248217000, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 29.08.2024.(Agravo de Instrumento, Nº 53575686320248217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabiana Azevedo da Cunha Barth, Julgado em: 09-03-2025)(grifei)*

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, o Superior Tribunal possui entendimento que *"a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais em razão do agravamento da aflição e angústia do segurado que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude da enfermidade "*[2].

Entretanto, é relevante destacar o entendimento do STJ sobre a recusa de cobertura por operadoras de planos de saúde, quando esta se fundamenta em dúvida razoável na interpretação do contrato. Caso a negativa da operadora se apoie em cláusulas contratuais ou na interpretação de normas regulatórias, como o rol da ANS, e desde que não haja afronta aos

deveres anexos ao pacto, como o da boa-fé, tal negativa não é considerada ilícita, tampouco enseja reparação por danos morais.

Nesse sentido:

> *AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. EXAME. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.*
> *1. Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.*
> *2. O julgador não está obrigado a repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes.*
> ***3. Não configura dano moral indenizável a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorrente de dúvida razoável na interpretação do contrato e atenção ao rol da ANS.***
> *4. Agravo interno desprovido.*
> *(AgInt no REsp n. 2.108.519/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)(grifei)*

No caso dos autos, contudo, a requerida negou o fornecimento de medicamento de uso ambulatorial, **cuja cobertura é obrigatória,** nos termos do art. 12, I, alínea "b", da Lei nº 9.656/98.

Assim, a ré agiu de forma abusiva, configurando violação aos atributos da personalidade da autora.

O dano sofrido pela autora, portadora de uma grave e incapacitante doença está consubstanciado na potencialização do sofrimento inerente à condição de sua saúde.

Trata-se, em verdade, de situação que extrapolou o simples descumprimento contratual, representando uma recusa injustificada e ofensiva às disposições contratuais e ao próprio rol da ANS.

A indenização, por seu turno, tem o condão de compensar o dano moral sofrido, bem como amplificar a responsabilização do agente responsável. Todavia, deve haver cautela na quantificação indenizatória, de modo a evitar enriquecimento ilícito. Em suma, o valor da indenização deve ser proporcional ao dano moral efetivamente sofrido pelo lesado.

Portanto, quando do arbitramento da indenização por danos morais, cabe ao julgador se utilizar dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a fixar montante apto a reparar o dano, sem, contudo, dar margem ao enriquecimento ilícito da parte.

Na hipótese, analisadas as peculiaridades do caso concreto e o valor normalmente fixado pelo TJRS em situações semelhantes[3], **fixo o dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).**

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **ADRIELI CATIANE SILVA RAMOS** contra a **UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA,** para o fim de **CONDENAR** a parte ré à obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento *Inebilizumab 100mg/10mL*, nos termos da prescrição médica; e **CONDENAR** a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 10.000,00. A quantia deverá ser corrigida, a contar desta sentença (Súmula 362, STJ), pelo IPCA, nos termos do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil. Deverá, ainda, ser acrescida de juros, estes incidem a contar da citação até a data do efetivo pagamento,no percentual correspondente a Taxa SELIC, deduzida do IPCA, conforme disposto no art. 406, §1º do Código Civil.

Considerando o teor da Súmula 326 do STJ[4], condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários ao procurador da parte autora, que fixo em 10% do valor da condenação, considerando o tempo decorrido, a natureza da causa e o zelo dos profissionais, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Em havendo apelação, não sendo do juízo *a quo* a competência para análise da admissibilidade, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões, remetendo-se, após ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens.

Com o trânsito em julgado, proceda-se a baixa.

Documento assinado eletronicamente por **VANCARLO ANDRE ANACLETO, Juiz de Direito**, em 23/06/2025, às 14:03:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10085075809v11** e o código CRC **bd1cd944**.

---

1. Agravo de Instrumento nº 5313189-71.2023.8.21.7000/RS. ↩
2. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022. ↩
3. Nesse sentido: Apelação Cível, Nº 50005653720208210091, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 27-11-2024. ↩
4. Súmula 326, STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. ↩